Autos: 0800336-35.2023.8.12.0040
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor:Daniel Fernandez Acosta
Réu: Município de Porto Murtinho e outro

Vistos, para sentença.

I. Relatório.

Daniel Fernandez Acosta ajuizou a presente "ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência" em desfavor de **Município de Porto Murtinho e Estado de Mato Grosso do Sul**, todos devidamente qualificados nos autos.

Consta na inicial que a parte autora se encontra com 75 anos de idade e foi diagnosticada com hiperplasia prostatica benigna (CID10 N40), tendo o médico especialista receitado para o tratamento a medicação tansulosina 0,4mg.

O fármaco se encontra registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Postulou pela concessão de tutela provisória de natureza antecipada para obrigar a parte ré fornecer os medicamentos, conforme receita médica, indeferida às p. 34-37.

No mérito, requereu a procedência do pedido para compelir a parte ré a fornecer a parte autora o fármaco acima mencionado, conforme descrito no laudo médico.

Fez os pedidos de estilo e juntou documentos (p. 11-25).

Parecer do NAT foi desfavorável (p. 29-33).

Citada, a parte ré apresentou resposta na forma de contestação (p. 42-52), arguindo, preliminarmente, a necessidade de inclusão da União no polo passivo com o deslocamento de competência à justiça federal.

No mérito, ressaltou a obrigação de fornecimento de medicação pelo ente público somente pode ser determinada se comprovada a presença cumulativa das condicionantes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ (Tema repetitivo nº 106).

Afirmou que a parte autora não preencheu os requisitos porque não houve o esgotamento do tratamento disponível, além de não haver fundamentação sobre a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde.

Requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, no caso de procedência: a) a apresentação obrigatória da receita médica atualizada para retirada do medicamento e autorizado o fornecimento com base no princípio ativo; b) não condenação do Estado no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública; c) o direcionamento da obrigação à União e ao Município e, no caso de execução forçada contra a parte ré, a garantia do direito ao ressarcimento; d) que não seja fixada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 26/04/2024 às 08:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800336-35.2023.8.12.0040 e código itUMepY2.

multa diária se determinada a execução forçada da obrigação; e) seja observado o PMVG se houver bloqueio de valores.

No mais, formulou os pedidos de estilo.

O Município de Porto Murtinho arguiu preliminar de competência da união, e no mérito requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, no caso de procedência o direcionamento da obrigação para a União, ficando a municipalidade responsável pela menor porcentagem quanto ao fornecimento dos fármacos.

No mais, fez o pleitos de praxe.

Houve impugnação (p. 66-70).

É o relatório.

Decido.

II. Fundamentação.

a) Da incompetência da Justiça Estadual.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão prolatada no Incidente de Assunção de Competência nº 14, determinou que a Justiça Estadual se abstenha de proferir decisões declinação de competência em ações que envolvem fornecimento de medicamentos pelo poder público[1].

Tendo isso em vista, assim como a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral no RE 1.366.243 (Tema 1.234) e liminar que proibiu a inclusão da União até julgamento do mencionado tema, rejeito a preliminar.

b) Do mérito.

O feito está em ordem. Não há preliminares pendentes ou nulidades a sanar.

O processo comporta o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil, eis que não vislumbro a necessidade de produção de outras provas em audiência, estando suficientemente instruído para solução da causa.

A parte autora pretende a condenação do Município de Porto Murtinho e Estado de Mato Grosso do Sul no fornecimento do medicamento tansulosina 0,4mg.

Inicialmente, aponto que a Constituição Federal de 1988 erigiu o direito à saúde ao patamar de direito fundamental, estabelecendo em seu art. 196 ser um direito a todos, garantido pelo Estado, ao qual compete o desenvolvimento de políticas que visem à promoção da saúde, redução do risco de doenças e, caso esta já se tenha consolidado, ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para proteção e recuperação da saúde.

A judicialização das políticas públicas de saúde vem atingindo números elevados de ações e de custos, especialmente em função da prescrição de medicamentos não fornecidos pelo sistema. O SUS, através de seus integrantes, a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios, é compelido à prestação de serviços de saúde, sob os

[1] Em sessão realizada em 8/6/2022, A Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 26/04/2024 às 08:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800336-35.2023.8.12.0040 e código itUMepY2.

princípios da universalidade e integralidade.

O art. 2º e parágrafo 1º da Lei nº 8.080/90 dispõe o seguinte:

> Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
>
> § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em apreço, os laudos médicos juntados às p. 13-15 dos autos comprovam o diagnóstico da moléstia que acomete a parte autora, assim como do medicamento receitado para o procedimento terapêutico ao qual deve se sujeitar.

O Parecer Técnico nº 4091/2023 registrou que apesar de registrados na ANVISA, o cloridrato de tansulosina não está padronizado na RENAME 2022 (p. 32).

> **VII - Se o pedido do autor é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em qualquer esfera, considerando especialmente, no caso de fármacos, os Programas de Medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus Protocolos Clínicos e a eficácia dos remédios disponibilizados na rede pública;**
>
> O Cloridrato de Tansulosina não está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022) ou outro ato normativo do SUS.

Em relação à obrigação do Estado de fornecer medicamento "off label", o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 106, fixou tese no sentido de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III) existência de registro na ANVISA do medicamento".

> Inicialmente cumpre ressaltar que a questão de fornecimento de medicamentos já possui ampla jurisprudência nesta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que tem entendido que o inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1991, incluído pela Lei n.12.401/2011, permite que seja deferido o fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. Dos julgados existentes é possível extrair alguns requisitos necessários para que o pleito seja deferido. O primeiro requisito consiste na demonstração da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento no tratamento, por meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado, devidamente expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Quanto à questão, consta das Jornadas de Direito da Saúde, realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, algumas diretrizes sobre a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, sendo que no enunciado n. 15 da I Jornada de Direito da Saúde asseverou-se que o laudo médico deve conter, pelo menos, as seguintes informações: "o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI); o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente,do nome de referência da substância; posologia; modo de administração; e período de tempo do tratamento; e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica". O segundo requisito consiste na devida comprovação da hipossuficiência daquele que requer o medicamento, ou seja, que a sua aquisição implique o comprometimento da sua própria subsistência e/ou de seu grupo familiar. Não se exige, pois, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente,a demonstração da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito. Por fim, o terceiro requisito a ser considerado é que o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.Esta exigência decorre de imposição legal, tendo em vista o artigo 19-T, inciso II, da Lei n.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 26/04/2024 às 08:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800336-35.2023.8.12.0040 e código itUMepY2.

> 8.080/1991, o qual dispõe que são vedados, em todas as esferas de gestão do SUS a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa. REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018 (Tema 106 – recurso repetitivo) (Info 625).

É o caso dos autos. O fármaco cloridrato de tansulosina possui registro na Anvisa (p. 32).

> **IV – Tratando-se de medicamento, deverá referir-se também a classe medicamentosa do fármaco e seu registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);**
>
> O Cloridrato de Tansulosina (outros produtos com ação no trato urinário) está registrado na ANVISA.

Quanto ao requisito da incapacidade financeira, entendo que encontra-se preenchido, uma vez que a parte autora está assistida pela Defensoria Pública, fato que presume a hipossuficiência econômica e incapacidade de arcar com a realização da consulta.

Foi demonstrada a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS no tratamento da doença. O doxazosina e a finasterida foram as alternativas sugeridas pelo parecer do NAT (p. 32). Todavia, ambos já estão sendo utilizados pela parte autora, porém não apresentaram os resultados esperados, sendo necessário a soma de mais um medicamento (p. 21).

> **8. A(s) alternativa(s) terapêutica(s) oferecida(s) pelo SUS para a(s) doença(s) já foi(ram) utilizada(s)?**
> (X) Sim ( ) Não
> **8.1. Em caso afirmativo especifique qual(is):**
> Doxazosina (2mg) Finasterina (5mg)
> **8.2. Por quanto tempo foi(ram) utilizada(s):**
> ( ) + de 01 ano (X) + de 06 meses ( ) – de 06 meses ( ) Prejudicado
> **8.3. O(A) paciente permanece em uso de tal(is) medicamento(s):**
> ( ) Sim* - Especifique qual(is): Finasterina. ( ) Não
> **8.4. Em relação ao(s) fármaco(s) do SUS utilizado(s) explicar eventual ineficácia e/ou contraindicação ao(à) paciente com base nos resultados clínicos produzidos:**
> A combinação Doxazosina e Finasterina não teve bom resultado. Agora se combinam a Tansulosina com Finasterina.

Portanto, atendidos todos os requisitos, a procedência do pedido é medida que se impõe.

> AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO TICAGRELOR PREENCHIDOS – TEMA 106 DO STJ – DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – ART. 300 DO CPC – REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TJMS. Agravo Interno Cível n. 1405502-22.2023.8.12.0000, São Gabriel do Oeste, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Bastos, j: 08/08/2023, p: 10/08/2023.
>
> APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS – TEMA 1.234 STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO PELA PARTE – PRELIMINAR AFASTADA – REQUISITOS DO TEMA N.º 106 PREENCHIDOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ministro relator do RE 1.366.243 concedeu, em parte, tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 do STF, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, vedando a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Presentes os requisitos elencados no Tema n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, para o fornecimento de remédio fora da lista do SUS, impõe-se seu fornecimento. Se a questão foi suficientemente debatida, não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados pelas partes. Recurso

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 26/04/2024 às 08:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800336-35.2023.8.12.0040 e código itUMepY2.

conhecido e desprovido. TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0821223-94.2022.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Fernando Paes de Campos, j: 17/08/2023, p: 21/08/2023.

As medicações deverão ser fornecidos na forma do princípio ativo, haja vista que não se pode obrigar a Administração Pública a fornecer um produto de uma determinada marca comercial sem que haja justificativa médica plausível para a restrição, uma vez que tal medida implicaria onerar indevidamente o poder público[2].

Anoto que o cumprimento da obrigação em relação ao remédio Ticagrelor, já que o NAT não direciona a obrigação a um dos réus, aplica-se a responsabilidade solidária[3].

III. Dispositivo.

Ante o exposto **sentencio o processo com resolução de mérito**, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e **julgo procedente** o pedido formulado por **Daniel Fernandez Acosta** em desfavor de **Município de Porto Murtinho e Estado de Mato Grosso do Sul** para condenar a parte ré no fornecimento à parte autora do medicamento cloridrato de tansulosina 0,4mg, no prazo de 30 dias, sob pena de sequestro de verbas públicas.

O cumprimento da obrigação deverá ser direcionado de forma solidária aos réus quanto ao fornecimento do fármaco.

Deverá a parte autora, a cada 3 (três) meses, apresentar perante o executor da medida relatórios e prescrições médicas devidamente atualizadas[4].

Deixo, por ora, de arbitrar multa por descumprimento, eis que a medida de sequestro, caso haja necessidade, mostra-se mais eficaz à obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente[5].

Sem custas, nos termos do art. 24, inc. I, da Lei nº 3.779/93.

Em atenção a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005 (Tema 1.002)[6], condeno o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Porto Murtinho no pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), à luz do art. 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC[7].

Aforados embargos de declaração, faça-se os autos conclusos na fila correspondente.

Interposto(s) recurso(s) de apelação, intime-se a(s) parte(s) adversa(s) para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal, consoante artigo 1.010, § 1º, do CPC.

[2] TJMS. Apelação Cível n. 0800581-26.2021.8.12.0037, Itaporã, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 19/01/2023, p: 23/01/2023.

[3] TJMS. Apelação Cível n. 0801679-87.2022.8.12.0012, Ivinhema, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 30/03/2023, p: 03/04/2023.

[4] Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. Enunciado nº 2 da I Jornada de Direito da Saúde.

[5] TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0800255-91.2020.8.12.0040, Porto Murtinho, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j: 18/07/2023, p: 19/07/2023

[6] I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Tese fixada no Tema 1002 do STF.

[7] Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável. Item 8 da edição nº 169 da ferramenta Jurisprudência em Teses do STJ.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 26/04/2024 às 08:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800336-35.2023.8.12.0040 e código itUMepY2.

Manejado recurso de apelação na forma adesiva, intime-se a(s) parte(s) adversa(s) para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal, na forma do artigo 1.010, § 2º, do CPC. Observe-se eventual prazo em dobro, nos termos dos artigos 180, 183 e 186 do CPC.

Na sequência, independentemente de juízo de admissibilidade, encaminhe-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso Sul para apreciação do(s) recurso(s).

Decorrido o prazo para recurso voluntário, remeta-se os autos àquele Sodalício para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I e § 1º, ambos do CPC[8].

Transitada em julgada, arquive-se os autos com as devidas anotações no sistema.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Porto Murtinho, data da assinatura digital.

Vinícius dos Anjos Borba
Juiz Substituto
(assinado por certificação digital)

[8] Art. 496, § 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 26/04/2024 às 08:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800336-35.2023.8.12.0040 e código itUMepY2.